

УДК: 616.71-006+004:618-089.87

¹Г.А.Серикбаев, ¹А.К. Косаев, ¹Д.А.Тулеуова, ²Б.М. Жумадуллаев, ¹Ж.О.Мауленов, ²А.А. Исалиев¹Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии²Центральная городская клиническая больница Медицинского центра УДП РК

Применение органосохраняющих операций при злокачественных и доброкачественных опухолях трубчатых костей

Аннотация. В настоящее время для лечения этой патологии применяются хирургический, лучевой и лекарственный методы, а также их комбинации. Хирургическое лечение перешло сегодня в качественно новое состояние – от калечащих операций к органосохраняющим.

Совершенно очевидно, что в равной мере общий результат лечения больного с патологией скелета определяют адекватная хирургическая тактика и адекватное замещение дефекта. На сегодняшний день для этого применяются аллотрансплантация костей, аутоотрансплантация костей, в том числе с использованием васкуляризованных трансплантатов, и эндопротезирование /2, 3/.

За период с 2006 по 2008 годы в отделении опухолей костей и мягких тканей КазНИИОиР проведено органосохраняющие хирургические вмешательства 49 больным с различными гистологическими типами опухолей.

Ключевые слова: органосохраняющие операции, опухоли, трубчатые кости.

Актуальность

Проблема лечения первичных злокачественных и доброкачественных опухолей костей представляется чрезвычайно актуальной. Так в Казахстане в 2007 году средний стандартизованный показатель частоты заболеваемости злокачественными опухолями костей и суставного хряща был равен 0,8 на 100 тыс. населения /1/.

В настоящее время для лечения этой патологии применяются хирургический, лучевой и лекарственный методы, а также их комбинации. Хирургическое лечение перешло сегодня в качественно новое состояние – от калечащих операций к органосохраняющим.

Совершенно очевидно, что в равной мере общий результат лечения больного с патологией скелета определяют адекватная хирургическая тактика и адекватное замещение дефекта. На сегодняшний день для этого применяются аллотрансплантация костей, аутоотрансплантация костей, в том числе с использованием васкуляризованных трансплантатов, и эндопротезирование /2, 3/.

Цель работы

Расширить показания к сохранным операциям, путём выбора адекватного варианта трансплантации для реконструкции обширных послеоперационных дефектов.

Материалы и методы

За период с 2006 по 2008 годы в отделении опухолей костей и мягких тканей КазНИИОиР проведено органосохраняющие хирургические вмешательства 49 больным с различными гистологическими типами опухолей.

Таблица 1 - Распределение больных по нозологиям

№	Нозология	Кол-во		
			м (%)	ж (%)
1	Остеогенная саркома	10 (4,1)	1	1
2	Хондросаркома	4	3	1
3	Злокачественная гистиоцитома	2 (4,1)	1	1
4	Гигантоклеточная опухоль	47 (89,7)	21	26
5	Ф и б р о з н а я дисплазия	1 (2,0)		1
6	Всего	64 (100)	25 (39,1)	39 (60,9)

Таблица 2. Локализация опухоли

№	Локализация опухоли	Количество (%)
1	Плечевая кость	7 (10,9)
2	Бедренная кость	22 (34,3)
3	Большеберцовая кость	24 (37,5)
4	Малоберцовая кость	2 (3,1)
5	Лучевая кость	9 (14,1)
6	Всего	64 (100)

У 2х с остеогенной саркомой в/3 плечевой кости, после верификации диагноза, проведено 3 курса полихимиотерапии, при этом получен хороший терапевтический эффект. Учитывая, что в настоящее время нет возможности установить плечевой эндопротез, произведена операция резекция в/3 плечевой кости с пластикой костным цементом и спицами Киршнера и 5 установлен эндопротез.

Осложнений в послеоперационном периоде не наблюдалось. Функция плечевого сустава восстановлена.

При рецидивных гигантоклеточных опухолях лучевой кости, когда есть вероятность озлокачествления опухоли, мы применяем резекцию лучевой кости с пластикой костным цементом.

По поводу опухолей в/3 бедра (злокачественной гистиоцитомы, гигантоклеточной опухоли и фиброзной дисплазии с патологическим переломом) произведена резекция в/3 бедренной кости с эндопротезированием

тазобедренного сустава онкологическим эндопротезом (МАТИ-ЦИТО 4 больным, ЭСИ 1 больному). С диагнозом гигантоклеточная опухоль н/3 бедренной кости в 3 случае произведена резекция н/3 бедренной кости с эндопротезированием коленного сустава онкологическим эндопротезом МАТИ-ЦИТО.

При гигантоклеточной опухоли таранной кости выполняется операция экскохлеация опухоли, криообработкой полости и заполнением полости костным цементом. В данном клиническом случае диагностировано тотальное поражение таранной кости. Во время операции был оставлен наружный корковый слой и полное замещение таранной кости костным цементом.

Осложнений в послеоперационном периоде не наблюдалось. Активизация больных на 6 сутки.

Виды проведенных оперативных вмешательств отражены в таблице 3.

Таблица 3 - Виды оперативных вмешательств

№	Вид операции	Количество
1	Резекция бедренной кости с эндопротезированием тазобедренного сустава	10
2	Резекция большеберцовой кости с эндопротезированием коленного сустава	6
3	Резекция плечевой кости с пластикой костным цементом, металлоостеосинтезом	7
4	Резекция лучевой кости с пластикой костным цементом, металлоостеосинтезом	2
5	Экскохлеация, криообработка, пластика костным цементом	39
6	Всего	64

Благодаря тесному взаимодействию онкохирургов, травматологов в специализированных центрах возможно выполнение органно-сохранных операций при опухолях костей.

Эндопротезирование и различные виды пластики, как альтернатива ампутации, - метод выбора при замещении пострезекционных дефектов суставных концов трубчатых костей.

Улучшение качества жизни больного, результат максимально возможного восстановления функции конечности в ранние сроки после оперативного вмешательства.

Тұжырым

Г.А.Серикбаев, А.К.Косаев, Д.А.Түлеуова, Б.М. Жумадуллаев, Ж.О.Мауленов, А.А. Исалиев

Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ

Медициналық орталық қалалық клиникалық аурухана УДП РК

Сүйектерде кездесетін біріншілік қатерсіз және қатерлі ісіктерді емдеу өте маңызды мәселе болып табылады. Қазақстанда 2007 жылғы орта стандартты көрсеткіш бойынша 100 мың тұрғынға шаққанда, сүйек және буын шеміршектерінде кездесетін қатерлі түзімдердің ауыршаңдылық жиілігі 0,8 ге сай келді.

Қазіргі таңда бұл патологиялық үрдісті емдеуде хирургиялық іс-шара, сәуле және дәріні әдістер немесе оларды кешенді түрде қолданылады.

Хирургиялық ем қазіргі таңда сапалы жаңа жағдайға бет алды, яғни кесіп алып тастатын іс-шарадан ағзаны сақтап қалушы хирургиялық іс-шараға көшуі.

2006 жыл мен 2008 жылдар аралығында ҚазОжРҒЗИ сүйек және жумсак тіндер ісігі бөлімінде ісіктің әртүрлі гистологиялық түрімен 49 науқасқа ағзаны сақтап қалушы хирургиялық іс-шара жасалды.

Түйінді сөздер: құбырлы сүйектердің қатерлі және қатерсіз ісігі, мүшесактау, операция.

Summary

G.A.Serikbaev, A.K.Kosayev, D.A.Tuleuova, B.M.Zhumadullaev, Zh.O.Maulenov, A.A.Isaliev.

Application conserving surgery for malignant and benign tumors of the long bones

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology Central Clinical Hospital Medical Center UDP RK.

The problem of treatment of bones primary malignant and good-quality tumours is represented extremely actual. So in 2007 the average standardized morbidity rate of bones and an articulate cartilage malignant tumours was equal in Kazakhstan 0,8 on 100 thousand population.

Now surgical, radiation and medicinal methods, and also their combinations are applied to treatment of this pathology. Surgical treatment has passed today in qualitatively new condition - from crippling operations to organ preservation.

From 2006 for 2008 in department of bones and soft tissue tumours of KazCRIO&R it is spent organ preservation surgical interventions of 49 patients with various histologic types of tumours.

Key words: malignant and benign tumors of long bones, sparing operation.